

Manual Lysis / Retained Placenta after Vaginal Delivery

Manage in OR

Unstable/PPH/High Risk

No epidural analgesia

Update Anesthesiologist
Update OR team
Transfer to OR

Manage in OR except special cases

**Shabbat/Chag/Oncall Special Cases
can Manage in LW**

+ Functioning epidural
+ Not risk for PPH
+ Stable patient

Decision of Anesthesiologist + Senior Obstetrician

Can Manage in LW

Day shift (not shabbat/chag/oncall)

+ Functioning epidural
+ Not risk for PPH
+ Stable patient

Decision of Anesthesiologist + Senior Obstetrician

All patients require

IV Fluids
Type/Screen, ABG
Hemodynamic monitoring of patient during procedure - HR, SaO2, NIBP
Anesthesiologist and Obstetrician committed to room during procedure
PPH Kit
Medications including vasopressors, tranexamic acid, local anesthetics
Available resuscitation equipment including oxygen, Ambu, Facemask
Suction connected and working

1. בשעות הבוקר (לא בשבת/חג/שעות תורנות): מיקום ביצוע הפעולה ייקבע על ידי רופא הנשים הבכיר ביותר הנוכח יחד עם הרופא מרדים הבכיר ביותר בצוות.
2. בשבת/חג/שעות התורנות: בחירת המחדל היא ביצוע פעולה בחדר ניתוח. מידה ומדובר ביולדת עם אלחוש אפידורלי שהשפיע טוב במהלך הלידה, ויציבה המודינמית ללא סימפטומטים (עליה בדופק, ירידת בלחץ דם, מדממת פעיל) וללא סיכון מוגבר ל PPH בהמשך, ללא תאומים וללא PPH בעבר וללא MAUAL LYSIS בעבר וכו', ניתן לשקול ביצוע פרוצדורה בחדר לידה ולדבר עם רופא מרדים לגביי החלטה לביצוע בחדר לידה, תחת מוניטור אימהי כמקובל.
2. בקשה לאלחוש ל- MANUAL LYSIS או לרביזיה – ישירות מרופא נשים הבכיר מול רופא מרדים על מנת להגדיר את הפרוצדורה ורמת הסיכון ולהסביר קבלת החלטה לביצוע בחדר לידה (בשבת/חג/שעות תורנות). יש לברר זמינות הרופא נשים וחיבור היולדת לניטור המודינמי על מנת לתזמן מתן תוספת לאפידורל.
3. בכל מקרה שרופא מרדים נותן תוספת לאלחוש אפידורלי בחדר לידה יש חיבור של היולדת לניטור – NIBP, קצב לב + סטורציה ותעוד ע"י אחות.
4. מתן אלחוש מומלץ להגיע לגובה אלחוש T8, 10-3 מ"ל של לידוקיין 1% או 2%
5. במקרה שבוצעה פרוצדורה בחדר לידה, מרגע תחילת הפרוצדורה עד הוצאת השליה, רופא מרדים נוכח על מנת להעריך יציבות היולדת, כמות הדימום, איכות הרדמה, צורך לעוד תוספת, צורך לעבור לחדר ניתוח – אלחוש נוסף / סיבוכים.
6. תיעוד בתיק היולדת – על איכות התחושה, ל"ד, בקצב לב, הערכת דימום בלידה אחרי מתן תוספת – ובתחילת פרוצדורה.
- 7 – החלטה לגביי צורת הרדמה בחדר ניתוח מבוססת על יציבות המודינמית וגורמיי סיכון של היולדת להרדמה כללית. ביולדת יציבה המודינמית, ללא הוראות נגד אלחוש נוראקסיאלי, יש עדיפות לביצוע אלחוש ספינלי.